PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA EN INFORMATICA

Sistema de Gestión de Camas y Monitoreo Clínico

Informe técnico de arquitectura y Especificación de requerimientos de software

Profesor: Francisco Muñoz

Integrantes:

1. Martin Lira Rodríguez
2. Martin González Romero
3. Gabriel Pehuenche Escobar
4. Gabriel Quiroz González
5. Nicolas Castellano Magnere

Asignatura:

Ingeniería De Software / INF2237-2

Fecha de entrega:

Lunes 16 de Noviembre de 2026

Portada de contenido

3. INTRODUCCIÓN

3.1 Descripción del Caso de Estudio y Problemática Detectada

En el ecosistema de la salud pública y privada contemporánea, la gestión eficiente de los recursos intrahospitalarios representa uno de los desafíos operacionales más críticos de la ingeniería de procesos. El presente proyecto aborda la problemática de la saturación y falta de visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de camas clínicas, así como la discontinuidad en el monitoreo preventivo de los signos vitales de los pacientes internados en recintos hospitalarios.

Actualmente, múltiples instituciones de salud operan bajo modelos de registro tradicionales o sistemas centralizados monolíticos que adolecen de sincronización inmediata. Esta desconexión genera "cuellos de botella" informacionales en el departamento de admisión, donde el personal administrativo desconoce el estado exacto de desocupación o higienización de una cama, retrasando el ingreso de pacientes en estado de vulnerabilidad. Asimismo, la falta de una plataforma integrada impide que el personal de enfermería y el cuerpo médico registren de forma ágil variables clínicas críticas (tales como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y presión arterial), aumentando el riesgo de omitir alertas tempranas ante descompensaciones hemodinámicas.

La persistencia de registros aislados en archivos planos o bitácoras manuales no solo vulnera los estándares de integridad y confidencialidad de los datos médicos recopilados, sino que limita la capacidad de los directores clínicos para proyectar la ocupación y planificar la expansión de la infraestructura hospitalaria, impactando directamente en la calidad de la atención y la seguridad del paciente

3.2 Usuarios Involucrados y Definición de Roles

Para solucionar de manera integral este escenario, el sistema propuesto interactúa con tres tipos de usuarios clave, delimitando estrictamente sus responsabilidades mediante un control de acceso basado en roles (RBAC):

- **Personal Administrativo de Admisión:** Este actor constituye la primera línea de interacción con el sistema. Su responsabilidad principal radica en el ingreso y gestión de la ficha de identificación del paciente (validando campos condicionantes según se trate de un paciente adulto o pediátrico), el control de las altas médicas y la consulta inicial de disponibilidad de camas dentro de las distintas áreas de la institución.

- **Personal Clínico (Médicos y Enfermeros):** Usuarios encargados de la interacción técnico-médica con la plataforma. Poseen los privilegios necesarios para asignar pacientes a camas específicas, actualizar en tiempo real las métricas del módulo de signos vitales, visualizar el historial clínico acumulado del internado y emitir las órdenes de traslado o alta médica.
- **Director Clínico / Jefe de Área:** Perfil de carácter estratégico y de gestión. Este usuario no interviene en la operación diaria de ingreso de pacientes, sino que supervisa los indicadores globales del sistema, tales como la tasa de ocupación por áreas, el rendimiento de la capacidad máxima y las estadísticas de alertas críticas disparadas, con el fin de optimizar la toma de decisiones presupuestarias y logísticas.

3.3 Naturaleza del Software Propuesto

La solución tecnológica diseñada se define metodológicamente como un **Sistema de Información Hospitalaria con enfoque especializado en la Gestión de Camas y Monitoreo Hemodinámico**.

A nivel arquitectónico, la naturaleza del software es modular y multiusuario, implementando el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esto garantiza la separación de la lógica de negocio (reglas de asignación de camas, validación de rangos biométricos) de la interfaz de usuario, permitiendo que el sistema escale desde una persistencia básica de datos hacia un motor de bases de datos relacionales robusto. El software está concebido para operar con altos estándares de concurrencia, asegurando que las modificaciones realizadas por el personal médico en las salas de hospitalización se reflejan instantáneamente en el mapa visual de la central de admisión.

3.4 Alternativas Actuales en el Mercado y el Porqué de nuestra Propuesta

Cuando miramos el mercado tecnológico de la salud, ya existen sistemas gigantescos que intentan resolver el problema de la gestión de hospitales. Sin embargo, al analizarlos de cerca, nos damos cuenta de por qué las instituciones medianas o regionales siguen teniendo problemas en su día a día y por qué se justifica crear nuestra propia solución.

El primer gran referente es **SAP Healthcare**. Es una plataforma masiva, utilizada por las corporaciones médicas más grandes del mundo. Resuelve absolutamente todo: desde las finanzas del hospital hasta las fichas clínicas. ¿El problema real? Su costo es astronómico y su implementación puede tardar años. Además, es un software tan complejo que requiere que el personal tome cursos larguísimos solo para aprender a usarlo. Por otro lado, tenemos soluciones más locales como **Philips Tasy**, muy popular en hospitales de Latinoamérica. Es un sistema excelente para conectar la parte administrativa

con la médica, pero peca de ser muy rígido. Modificar una función o adaptarlo a las necesidades específicas de un hospital clínico mediano es un proceso lento que depende amarrarse al proveedor. Además, sus interfaces visuales suelen ser antiguas, lo que dificulta que el personal de admisión vea de forma intuitiva qué camas están realmente libres o en proceso de limpieza.

¿Dónde entra nuestra solución?

Nuestro software no pretende competir con estos gigantes en el área de finanzas o farmacia. Nos enfocamos en lo que ellos descuidan por ser tan grandes: **la agilidad en el piso de hospitalización**. Al centrarnos exclusivamente en conectar al administrativo de admisión con el médico a través de un mapa de camas dinámico y un control de signos vitales con alertas visuales, logramos tres ventajas clave:

- Una interfaz tan sencilla que el personal médico puede usarla con solo minutos de inducción.
- Un sistema modular que se adapta rápido a los cambios de la institución sin costos millonarios de consultoría.
- Un enfoque directo en salvar vidas mediante la detección oportuna de alertas críticas en el monitoreo diario, algo que en los grandes softwares suele quedar oculto entre cientos de menús.

3.5 Breve Resumen de los Contenidos del Informe

El presente documento técnico detalla de forma metodológica el ciclo de vida del desarrollo de la solución, estructurando en los apartados que se describen a continuación:

- **Análisis de Requerimientos:** Capítulo donde se desglosan formalmente las necesidades del sistema, especificando los 15 requerimientos funcionales mínimos obligatorios y los requerimientos no funcionales orientados a la calidad del software.
- **Modelado de Diagramas de Casos de Uso y Procesos:** Sección dedicada a la representación gráfica del comportamiento del sistema, incorporando un diagrama de procesos de negocio (BPMN) y el modelado UML de casos de uso junto con sus respectivas fichas descriptivas de flujo.
- **Justificación del Modelo de Desarrollo:** Apartado que argumenta la selección de la metodología de ingeniería de software utilizada (Scrum), detallando el enfoque de ciclos iterativos y el cronograma general del proyecto mediante un Diagrama de Gantt.
- **Herramientas CASE:** Detalle de los entornos de software utilizados para automatizar el diseño, control de versiones y documentación del sistema (GitHub, Visual Paradigm, Figma).

- **Soporte de Software, Seguridad y Calidad:** Espacio donde se definen las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo, los mecanismos de mitigación de vulnerabilidades y la alineación de la propuesta con el estándar internacional de calidad **ISO/IEC 25010**.
- **Diseño de Mockups:** Presentación visual de las interfaces del sistema, justificadas bajo principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI).

4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1 Descripción del Caso de Estudio

El objeto de este análisis es el diseño y la especificación de un **sistema integrado de información hospitalaria**, desarrollado específicamente para la **gestión de camas clínicas y el monitoreo preventivo**. El objetivo principal del software es optimizar la transmisión de datos clínicos para mitigar riesgos operativos y asistenciales en pacientes de alta vulnerabilidad. El proceso comienza con el registro administrativo de los pacientes ingresados, flujo que anteriormente presentaba una brecha de información debido a que la disponibilidad de camas y salas se controlaba mediante bitácoras manuales o sistemas aislados, impidiendo la sincronización de los recursos en tiempo real.

Una vez registrado en la plataforma, el paciente es clasificado por rango grupo de edad en las categorías Adulto o Pediátrico, lo que activa reglas de negocio estrictas para la validación de datos complementarios. Para los pacientes adultos es obligatoria la incorporación de su sistema de previsión de salud, mientras que para los menores de edad se exige la identificación de su apoderado legal. Posteriormente, en el área de hospitalización, el personal de salud asume la responsabilidad de registrar las variables biomédicas. Los sistemas tradicionales carecen de mecanismos automáticos de notificación, provocando que las descompensaciones clínicas del paciente, tales como caídas de saturación, picos de presión arterial o taquicardias, se detecten de manera reactiva. En conclusión, este documento técnico traduce los problemas descritos en requerimientos de software formales, utilizando metodologías estructuradas de ingeniería de requisitos para garantizar una solución proactiva y centralizada.

4.2 Identificación de Requerimientos

4.2.1 Requerimientos de Usuario

A nivel general, los Requerimientos de Usuario (RU) son simplemente lo que el cliente necesita que haga el sistema, explicado con sus propias palabras, sin tecnicismos ni enredos informáticos.

- Personal Administrativo (Admisión)

RU-ADM-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-01
Actor	Personal de admisión
Requerimiento	El personal de admisión necesita ingresar la información básica de identificación de un paciente de forma rápida al momento de su llegada, asegurando que se capturen datos específicos dependiendo de si es un adulto o un niño.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-02
Actor	Usuario administrativo
Requerimiento	El usuario administrativo requiere consultar de manera visual e inmediata cuáles camas de hospitalización están vacías y cuáles están ocupadas dentro de cada área médica antes de asignar a un paciente.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-03
Actor	Usuario administrativo
Requerimiento	Se requiere un mecanismo para registrar la salida oficial (alta) de un paciente del sistema, de modo que la infraestructura clínica que estaba utilizando quede libre inmediatamente para nuevos ingresos.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-04 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-04
Actor	Personal de admisión
Requerimiento	El personal requiere listar de manera independiente a aquellos pacientes que ya están registrados en el hospital pero que se encuentran a la espera de que se les asigne una cama libre.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

- Personal Clínico (Médicos y Enfermeros)

RU-CLI-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-01
Actor	Personal clínico
Requerimiento	El personal clínico requiere una función que le permita ingresar los parámetros de los signos vitales medidos al paciente en su rutina de control regular.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-02
Actor	Médicos y enfermeros
Requerimiento	Los médicos y enfermeros necesitan revisar de forma cronológica la evolución o el historial de los signos vitales anteriores de un paciente internado para evaluar si está mejorando o empeorando.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-03
Actor	Personal clínico
Requerimiento	El sistema debe alertar visualmente al profesional de la salud de forma automática e inmediata si los signos vitales recién digitados representan un peligro para la estabilidad del paciente.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-04 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-04
Actor	Equipo de salud
Requerimiento	El equipo de salud requiere registrar el traslado físico de un paciente desde una cama hacia otra (ya sea dentro de la misma sala o a un área clínica diferente), actualizando sus ubicaciones virtuales correspondientes.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

- Director Clínico / Jefe de Área

RU-DIR-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-01
Actor	Dirección del hospital
Requerimiento	La dirección del hospital requiere ver un panel de control con estadísticas e indicadores del rendimiento clínico en tiempo real, tales como el porcentaje de ocupación general de camas por áreas y la cantidad de alertas médicas disparadas.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

RU-DIR-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-02
Actor	Jefe de área
Requerimiento	El jefe de área requiere que el software impida de forma estricta que personal no autorizado (como administrativos o usuarios ajenos al área médica) pueda ver o alterar la información confidencial de las fichas biométricas de los pacientes internados.
Tipo	No funcional
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta

RU-DIR-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-03
Actor	Dirección del hospital
Requerimiento	Se requiere que la plataforma sea altamente confiable y se mantenga operativa de manera continua, minimizando la probabilidad de caídas del sistema que puedan interrumpir la supervisión de los pacientes críticos.
Tipo	No funcional
Categoría	Confiabilidad / Disponibilidad
Prioridad	Alta

4.2.2 Requerimientos Funcionales del Sistema

A nivel general, los Requerimientos Funcionales (RF) son la traducción técnica de las necesidades del usuario. Si el Requerimiento de Usuario (RU) te dice *qué* quiere la persona, el Requerimiento Funcional detalla exactamente las operaciones, cálculos y transformaciones de datos que el software debe hacer tras bambalinas para cumplir ese deseo.

- Módulo de Admisión y Registro de Pacientes

Ficha de Requerimiento Funcional 01	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-01
Nombre	Captura y Validación de Datos de Identificación de Pacientes.
Descripción	El sistema debe proveer un formulario para registrar un paciente capturando de manera obligatoria su RUT (con dígito verificador), Nombre Completo y Edad en años.
Entrada	Cadena de caracteres del RUT, cadena de texto para Nombre, número entero para Edad.
Salida	Instancia de paciente creada en memoria o mensaje de excepción en caso de RUT inválido.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 02	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-02
Nombre	Clasificación Polimórfica Automática por Rango Etario.
Descripción	Al guardar el registro, el sistema debe evaluar la edad ingresada. Si el valor es menor a 18 años, el software debe clasificar al paciente internamente como subtipo "Niño". Si es igual o mayor a 18 años, debe clasificarlo como subtipo "Adulto".
Entrada	Atributo de edad del paciente.
Salida	Instanciación de objeto especializado (Nino o Adulto) en las colecciones del sistema.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 03	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-03
Nombre	Control de Obligatoriedad de Previsión para Pacientes Adultos.
Descripción	Si el paciente ha sido clasificado como "Adulto", el sistema debe condicionar el guardado a la selección obligatoria de un Sistema de Previsión de salud (ej: FONASA, ISAPRE, Particular).
Entrada	Selección del campo de texto de previsión de salud.
Salida	Aceptación del registro o bloqueo del flujo con advertencia por campo faltante.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 04	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-04
Nombre	Validación y Registro Obligatorio de Apoderado para Pacientes Pediátricos.
Descripción	Si el paciente ha sido clasificado como "Niño", el sistema debe exigir obligatoriamente el ingreso del Nombre y el RUT válido del apoderado legal antes de persistir los datos.
Entrada	Cadena de caracteres de RUT de apoderado y cadena de texto de Nombre de apoderado.
Salida	Persistencia de la relación de tutoría o lanzamiento de una excepción de validación.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 05	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-05
Nombre	Listado de Pacientes en Estado de Espera (Sin Asignar).
Descripción	El sistema debe permitir al personal de admisión listar en una interfaz dedicada a todos los pacientes que han sido registrados con éxito pero que aún poseen el identificador de cama asociado en valor cero o nulo.
Entrada	Petición de despliegue mediante evento de interfaz.
Salida	Matriz de datos o lista en pantalla con los pacientes en estado "Sin Asignar".
Prioridad	Alta

- Módulo de Gestión de Infraestructura Hospitalaria y Camas

Ficha de Requerimiento Funcional 06	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-06
Nombre	Configuración de Áreas Clínicas e Integridad de Capacidad Máxima.
Descripción	El sistema debe permitir crear áreas hospitalarias asignándoles un código numérico único, nombre descriptivo y un número entero que defina su capacidad máxima de camas.
Entrada	Entero de Código de Área, texto de Nombre de Área, entero de Capacidad Máxima.
Salida	Confirmación de creación del Área o denegación por código duplicado.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 07	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-07
Nombre	Inserción Indizada de Camas Clínicas por Área.
Descripción	El sistema debe permitir incorporar camas clínicas asociándolas de forma indexada a un código de área existente, solicitando un ID de cama único y una categoría (ej: UCI, UTI, Media, Básica).
Entrada	ID de cama, categoría de la cama y código del área de destino.
Salida	Vinculación del objeto Cama a la lista interna del área correspondiente.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 08	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-08
Nombre	Consulta de Disponibilidad en Tiempo Real del Mapa de Camas.
Descripción	El sistema debe proveer una función que recorra los arreglos de camas clínicas y devuelva un mapa visual que indique el estado de disponibilidad numérico (0 para Disponible, 1 para Ocupada) por área.
Entrada	ID o código del área clínica a consultar.
Salida	Despliegue dinámico del estado de ocupación de las camas pertenecientes al área.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 09	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-09
Nombre	Exclusión Mutua de Asignación sobre Camas Ocupadas.
Descripción	El sistema debe impedir la ejecución del método de ocupación si la propiedad de disponibilidad de la cama seleccionada es igual a 1 (Ocupada), bloqueando la sobrescritura de pacientes.
Entrada	Intento de asignación de ID de paciente a un ID de cama ocupada.
Salida	Lanzamiento de excepción de negocio ("Cama Ocupada") y cancelación del proceso.
Prioridad	Alta

- Módulo Clínico y Monitoreo Hemodinámico

Ficha de Requerimiento Funcional 10	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-10
Nombre	Captura e Inserción de Métricas de Signos Vitales.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario clínico ingresar los signos vitales actuales de un paciente internado, obligando a llenar los campos de Frecuencia Cardíaca, Presión Arterial, Saturación de Oxígeno y Temperatura.
Entrada	Entero (FC), Real (PA), Entero (Saturación), Real (Temperatura).
Salida	Objeto SignosVitales instanciado y enlazado al objeto Paciente respectivo.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 11	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-11
Nombre	Registro y Almacenamiento Histórico Clínico.
Descripción	Cada vez que se actualicen los signos vitales, el sistema no debe sobrescribir los anteriores; debe insertar el registro en una estructura de lista enlazada interna para conservar el historial cronológico por paciente.
Entrada	Nuevos valores de signos vitales junto con la estampa de fecha y hora del sistema.
Salida	Estructura histórica del paciente actualizada con el nuevo nodo de datos.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 12	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-12
Nombre	Asignación Dinámica de Camas a Pacientes en Espera.
Descripción	El sistema debe permitir tomar un paciente en estado "Sin Asignar" e ingresarlo a una cama cuyo estado de disponibilidad sea 0 (Disponible), cambiando el estado de la cama a 1 (Ocupada) de manera síncrona.
Entrada	ID del Paciente en espera e ID de la Cama disponible seleccionada.
Salida	Cama enlazada al paciente, disponibilidad modificada y remoción del paciente de la lista de espera.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 13	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-13
Nombre	Traslado Atómico de Pacientes Intrahospitalario.
Descripción	El sistema debe permitir trasladar un paciente de una cama de origen a una de destino en un solo bloque operativo. Debe liberar la cama de origen (disponibilidad = 0) y ocupar la de destino (disponibilidad = 1).
Entrada	ID del paciente, ID de cama actual e ID de la nueva cama de destino.
Salida	Estados de ambas camas actualizados y propiedad de localización del paciente modificada.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 14	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-14
Nombre	Disparo Automático de Alertas Visuales Críticas.
Descripción	Al ingresar signos vitales, el software evaluará los rangos. Si la Saturación es < 90%, o la Temperatura es > 38.5°C, el sistema debe gatillar una alerta visual intermitente de alta prioridad en la interfaz central.
Entrada	Evaluación condicional de los atributos numéricos de SignosVitales.
Salida	Estado de alarma activado en la interfaz gráfica del pabellón correspondiente.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 15	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-15
Nombre	Tramitación de Alta Médica y Liberación de Recursos.
Descripción	El sistema debe permitir registrar el egreso o alta de un paciente. Al ejecutar esta acción, el software romperá el enlace entre el paciente y la cama, modificando la disponibilidad de la cama a 0 de forma inmediata.
Entrada	Orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado.
Salida	Cama liberada y disponible para admisión; objeto paciente archivado en el histórico.
Prioridad	Alta

4.2.3 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones, propiedades emergentes y criterios de calidad bajo los cuales debe operar el software clínico, asegurando que el comportamiento del producto responda a las demandas de un entorno crítico de salud.

- Requerimientos del Producto (Eficiencia, Fiabilidad, Usabilidad y Seguridad)

Ficha de Requerimiento No Funcional 01	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-01
Nombre	Eficiencia de Desempeño (Tiempo de Respuesta)
Métrica Cuantitativa	El tiempo promedio de respuesta del servidor ante la inserción de controles de signos vitales (RF-10) o la actualización transaccional de un traslado clínico (RF-13) no debe exceder los 2.0 segundos.
Criterio de Verificación	Esta métrica debe cumplirse bajo un escenario de carga de estrés simulada de hasta 50 peticiones concurrentes ejecutadas de forma simultánea desde las terminales de enfermería conectadas a la red local intrahospitalaria.

Ficha de Requerimiento No Funcional 02	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-02
Nombre	Fiabilidad (Tasa de Disponibilidad de la Plataforma)
Métrica Cuantitativa	Al clasificarse como un software de gestión crítico para la vida de los pacientes, el sistema debe garantizar una disponibilidad operativa mínima del 99.9% del tiempo en régimen de funcionamiento 24/7.
Criterio de Verificación	El tiempo promedio entre fallas (MTBF) del software no debe ser inferior a 3.000 horas continuas de ejecución. El tiempo medio de recuperación (MTTR) ante una caída del servicio de persistencia de datos no debe superar los 5 minutos.

Ficha de Requerimiento No Funcional 03	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-03
Nombre	Usabilidad (Operatividad y Tiempo de Capacitación)
Métrica Cuantitativa	El diseño de la interfaz gráfica (UI) para el mapa dinámico de camas y el ingreso clínico debe ser lo suficientemente intuitivo como para requerir un tiempo máximo de capacitación teórica de 30 minutos para el personal de salud antes de operar de forma fluida.
Criterio de Verificación	Evaluado mediante pruebas de usabilidad donde el 95% de los enfermeros del grupo de control logren completar el flujo de admisión y el ingreso de métricas biométricas sin asistencia técnica externa en su primer intento.

Ficha de Requerimiento No Funcional 04	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-04
Nombre	Seguridad (Autenticación y Control de Accesos)
Métrica Cuantitativa	El sistema debe aplicar un algoritmo de hash SHA-256 sobre todas las claves de usuario almacenadas en el sistema y forzar el cierre automático de la sesión activa tras un tiempo de inactividad lineal de 10 minutos en cualquier estación terminal del pabellón clínico.
Criterio de Verificación	Intentos de inyección SQL o de fuerza bruta sobre el Login deben bloquear la cuenta de usuario de forma síncrona por un periodo mandatorio de 15 minutos tras alcanzar un límite estricto de 5 intentos fallidos consecutivos.

- Requerimientos Organizacionales

Ficha de Requerimiento No Funcional 05	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-05
Nombre	Mantenibilidad (Estándares de Codificación de la Cátedra)
Métrica Cuantitativa	El código fuente del prototipo dinámico desarrollado en Java debe seguir las directrices estructurales internas para asegurar una migración de datos fluida desde los archivos planos (`.txt`) actuales hacia una base de datos relacional robusta.
Criterio de Verificación	El 100% del software debe respetar las convenciones de nombres estándar de la industria (clases en UpperCamelCase, variables y métodos en lowerCamelCase). Las funciones críticas de la lógica de negocio (como la clasificación automática de edad del RF-02) deben alcanzar una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% en las herramientas de análisis estático de código.

- Requerimientos Externos (Legislativos y de Privacidad)

Ficha de Requerimiento No Funcional 06	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-06
Nombre	Cumplimiento de Legislación y Privacidad de Datos Clínicos
Métrica Cuantitativa	El 100% de los datos clínicos sensibles, incluyendo fichas médicas, RUT e historial de signos vitales de los pacientes, deben almacenarse, tratarse y transmitirse utilizando cifrado AES-256, evitando el acceso no autorizado a la información.
Criterio de Verificación	El 100% de los mecanismos de almacenamiento y tratamiento de datos debe cumplir con la legislación chilena aplicable, incluyendo la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley 20.584 sobre los derechos y deberes de las personas en relación con su atención de salud. Se debe verificar que ningún archivo temporal de texto almacene datos clínicos o biométricos en texto claro legible.

5. MODELADO DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Y PROCESOS

- Diagrama BPMN:

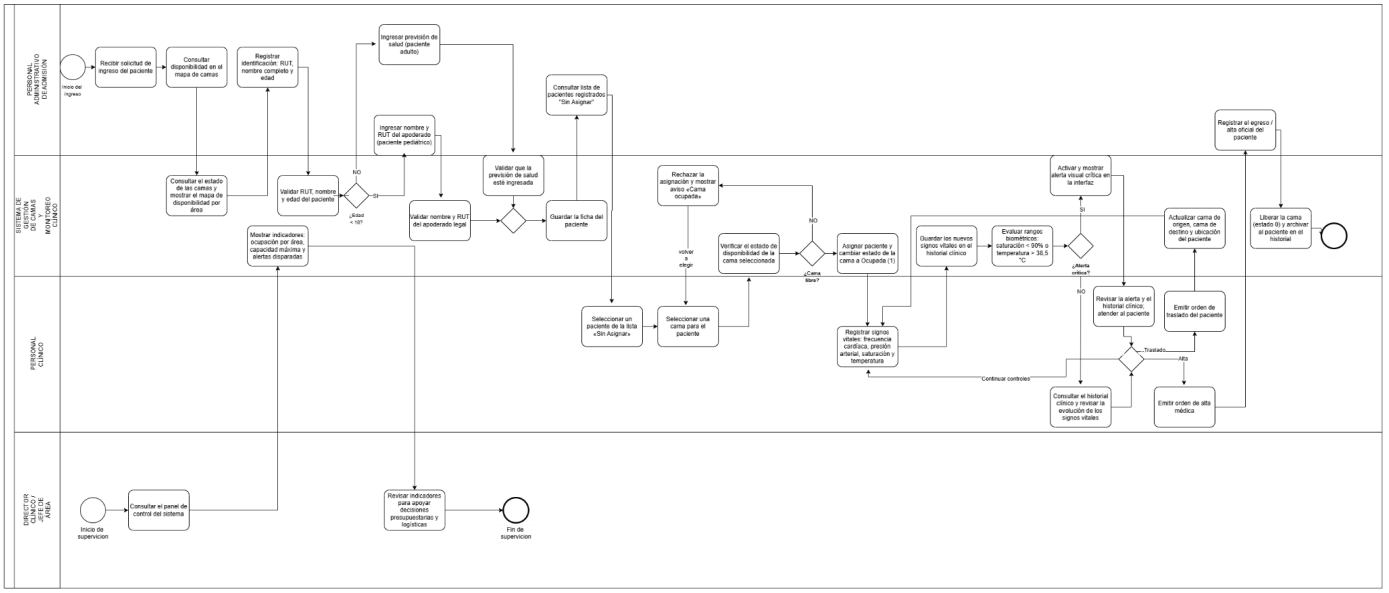
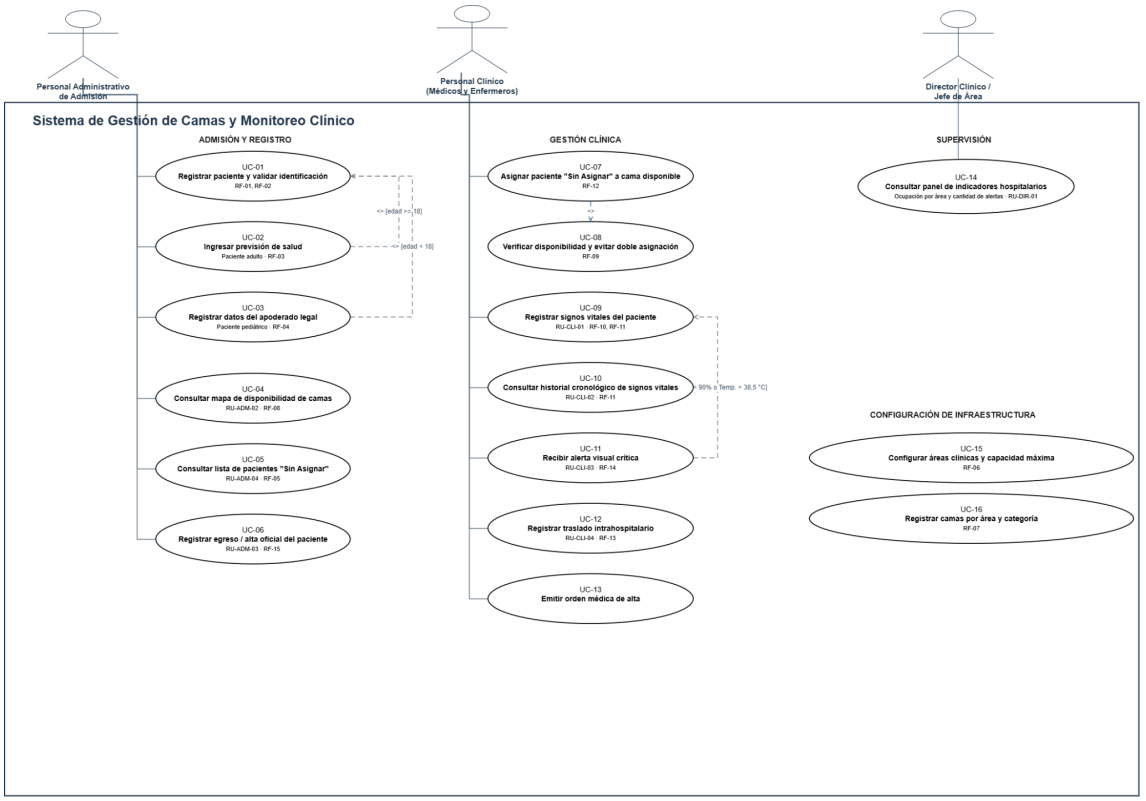


imagen vectorizar para que al hacer zoom no se baje la calidad

- Diagrama de casos de usos principal:



5.3 Descripción de Casos de Uso

Las siguientes fichas describen los casos de uso identificados en el diagrama principal del Sistema de Gestión de Camas y Monitoreo Clínico. Cada caso especifica los actores involucrados, el flujo principal de eventos, las precondiciones y las postcondiciones correspondientes.

Las descripciones se elaboran a partir de los requerimientos de usuario (RU), requerimientos funcionales (RF) y las responsabilidades de los perfiles establecidos en el documento del proyecto.

UC-01 – Registrar paciente y validar identificación

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-01, RF-02 y RU-ADM-01.

Precondiciones:

- El personal administrativo interactúa con el sistema conforme a los permisos de su rol.
- Se dispone del RUT, nombre completo y edad del paciente.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita registrar un paciente.
2. El sistema presenta el formulario de identificación.
3. El personal administrativo ingresa el RUT, el nombre completo y la edad del paciente.
4. El sistema valida el formato del RUT y los datos de identificación ingresados.
5. El sistema evalúa la edad y clasifica al paciente: menor de 18 años como “Niño” o igual o mayor de 18 años como “Adulto”.
6. Según la clasificación, el sistema solicita los datos complementarios correspondientes mediante UC-02 o UC-03.
7. Una vez satisfechas las validaciones aplicables, el sistema crea y guarda la ficha del paciente.

Postcondiciones:

- La ficha del paciente queda creada con su identificación y clasificación etaria.
- Si el RUT es inválido, el sistema genera la excepción indicada en RF-01 y no se completa la creación.

UC-02 – Ingresar previsión de salud

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-03; condición de extensión de UC-01 (paciente adulto).

Precondiciones:

- UC-01 se encuentra en ejecución.
- El sistema clasificó al paciente como “Adulto” (edad igual o mayor a 18 años).

Flujo principal de eventos:

1. El sistema exige la selección de un sistema de previsión de salud para el paciente adulto.
2. El personal administrativo selecciona la previsión correspondiente (el documento menciona como ejemplos FONASA, ISAPRE o Particular).
3. El sistema verifica que se haya seleccionado una previsión.
4. Si el campo está informado, el flujo de registro puede continuar. Si falta, el sistema bloquea el guardado y advierte que el campo es obligatorio.

Postcondiciones:

- La previsión de salud queda informada para el registro del paciente adulto, o el guardado permanece bloqueado por campo faltante.

UC-03 – Registrar datos del apoderado legal

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-04; condición de extensión de UC-01 (paciente pediátrico).

Precondiciones:

- UC-01 se encuentra en ejecución.
- El sistema clasificó al paciente como “Niño” (edad menor a 18 años).

Flujo principal de eventos:

1. El sistema exige los datos del apoderado legal del paciente pediátrico.
2. El personal administrativo ingresa el nombre y el RUT del apoderado.
3. El sistema valida que ambos datos estén presentes y sean válidos según las reglas documentadas.
4. Si la validación es satisfactoria, el sistema persiste la relación de tutoría. Si no, genera una excepción de validación.

Postcondiciones:

- La relación entre el paciente pediátrico y su apoderado queda registrada, o se genera la excepción de validación correspondiente.

UC-04 – Consultar mapa de disponibilidad de camas

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-02 y RF-08.

Precondiciones:

- El usuario administrativo tiene acceso a la función de consulta.
- Se proporciona el ID o código del área clínica que se desea consultar.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita consultar la disponibilidad de camas de un área clínica.
2. El sistema recibe el ID o código del área.
3. El sistema recorre los registros de camas clínicas asociados al área consultada.
4. El sistema obtiene el estado de disponibilidad de cada cama: 0 para disponible y 1 para ocupada.
5. El sistema despliega el mapa visual con el estado de ocupación de las camas del área.

Postcondiciones:

- El mapa visual de disponibilidad del área queda presentado al personal administrativo con los estados numéricos definidos.

UC-05 – Consultar lista de pacientes “Sin Asignar”

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-04 y RF-05.

Precondiciones:

- El personal administrativo tiene acceso a la función de consulta.
- Existen registros de pacientes incorporados al sistema; la lista puede no contener resultados.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita visualizar la lista de pacientes “Sin Asignar”.
2. El sistema identifica los pacientes registrados correctamente cuyo identificador de cama asociado tiene valor cero o nulo.
3. El sistema presenta la matriz de datos o lista de pacientes que cumplen esa condición.

Postcondiciones:

- La lista de pacientes registrados que aún no tienen una cama asignada queda disponible para consulta.

UC-06 – Registrar egreso / alta oficial del paciente

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-03 y RF-15.

Precondiciones:

- El paciente se encuentra hospitalizado y asociado a una cama.
- Se dispone de la orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado, indicada como entrada de RF-15.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita registrar el egreso o alta oficial del paciente.
2. El personal administrativo identifica al paciente mediante su ID y se dispone de la orden de alta correspondiente.
3. El sistema rompe el enlace entre el paciente y la cama asociada.
4. El sistema modifica la disponibilidad de la cama a 0 (libre).
5. El sistema archiva el objeto del paciente en el histórico.

Postcondiciones:

- El egreso queda registrado.
- La cama queda liberada y disponible para admisión.
- El objeto del paciente queda archivado en el histórico.

UC-07 – Asignar paciente “Sin Asignar” a cama disponible

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RF-12 y responsabilidades de asignación descritas en la sección 3.2.

Precondiciones:

- Existe un paciente identificado en estado “Sin Asignar”.
- Se identifica una cama cuyo estado de disponibilidad es 0 (disponible).

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico solicita asignar un paciente en estado “Sin Asignar”.
2. Se proporciona el ID del paciente y el ID de la cama disponible seleccionada.
3. El sistema ejecuta UC-08 para verificar que la cama no esté ocupada y evitar una doble asignación.
4. Si la verificación permite continuar, el sistema enlaza el paciente con la cama seleccionada.
5. El sistema cambia sincrónicamente el estado de disponibilidad de la cama a 1 (ocupada).
6. El sistema retira al paciente de la lista “Sin Asignar”.

Postcondiciones:

- El paciente queda asociado a la cama seleccionada.
- La cama queda marcada como ocupada (1).
- El paciente deja de aparecer en la lista “Sin Asignar”.

UC-08 – Verificar disponibilidad y evitar doble asignación

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), como actor que inicia UC-07; la verificación es realizada por el sistema.

Referencia documental: RF-09; relación “include” desde UC-07.

Precondiciones:

- Se está ejecutando UC-07.
- Se ha proporcionado el ID de una cama seleccionada para la asignación.

Flujo principal de eventos:

1. Durante UC-07, el sistema consulta la propiedad de disponibilidad de la cama seleccionada.
2. Si el valor es 0 (disponible), el sistema permite que UC-07 continúe con la asignación.
3. Si el valor es 1 (ocupada), el sistema lanza la excepción de negocio “Cama Ocupada”.
4. Ante la excepción, el sistema cancela el proceso de asignación e impide sobrescribir la ocupación existente.

Postcondiciones:

- La asignación solo puede continuar cuando la cama está disponible.
- Si la cama está ocupada, no se sobrescribe su asignación y el proceso queda cancelado.

UC-09 – Registrar signos vitales del paciente

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RU-CLI-01, RF-10 y RF-11.

Precondiciones:

- El paciente se encuentra internado y puede identificarse mediante su ID.
- El personal clínico dispone de los valores actuales de signos vitales que debe ingresar.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico solicita registrar los signos vitales actuales de un paciente internado.
2. El usuario ingresa frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura.
3. El sistema recibe los valores y los vincula al paciente correspondiente.
4. El sistema genera un nuevo registro histórico con la fecha y hora del sistema.
5. El sistema incorpora el nuevo registro al historial cronológico sin sobrescribir los registros anteriores.
6. Al ingresar los valores, el sistema evalúa las condiciones de alerta establecidas en RF-14, si se cumple la condición, se ejecuta UC-11.

Postcondiciones:

- Los nuevos signos vitales quedan enlazados al paciente.
- El historial clínico conserva los registros anteriores y agrega el nuevo registro con fecha y hora.

UC-10 – Consultar historial cronológico de signos vitales

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RU-CLI-02 y RF-11.

Precondiciones:

- El paciente internado está identificado.
- Existen registros históricos de signos vitales asociados al paciente para que puedan ser consultados.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico solicita consultar el historial de signos vitales de un paciente internado.
2. El sistema recupera los registros históricos asociados al paciente.
3. El sistema presenta los registros en orden cronológico.
4. El personal clínico revisa la evolución de los signos vitales para evaluar si el estado del paciente mejora o empeora.

Postcondiciones:

- El historial cronológico queda visualizado para el personal clínico.
- La consulta no modifica ni sobrescribe los registros históricos.

UC-11 – Recibir alerta visual crítica

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), como destinatario de la alerta; el sistema genera y muestra la alerta automáticamente.

Referencia documental: RU-CLI-03, RF-14; relación “extend” de UC-09 bajo condición crítica.

Precondiciones:

- Se han ingresado signos vitales mediante UC-09.
- La saturación de oxígeno es menor a 90% o la temperatura es mayor a 38,5 °C.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema evalúa los valores de signos vitales ingresados.
2. El sistema detecta que la saturación es menor a 90% o que la temperatura supera los 38,5 °C.
3. El sistema activa una alerta visual intermitente de prioridad alta en la interfaz gráfica correspondiente.
4. El personal clínico recibe visualmente la alerta.

Postcondiciones:

- El estado de alarma queda activado en la interfaz gráfica correspondiente.
- El personal clínico cuenta con la notificación visual de la condición crítica detectada.

UC-12 – Registrar traslado intrahospitalario

Actor(es) involucrado(s): Equipo de salud / Personal Clínico.

Referencia documental: RU-CLI-04, RF-13 y responsabilidades del personal clínico en la sección 3.2.

Precondiciones:

- El paciente está identificado y asociado a una cama de origen.
- Se dispone del ID del paciente, del ID de la cama actual y del ID de la nueva cama de destino.

Flujo principal de eventos:

1. El equipo de salud solicita registrar el traslado físico del paciente.
2. El usuario proporciona el ID del paciente, el ID de la cama de origen y el ID de la cama de destino.
3. El sistema ejecuta la actualización del traslado en un solo bloque operativo.
4. El sistema libera la cama de origen y establece su disponibilidad en 0 (libre).
5. El sistema ocupa la cama de destino y establece su disponibilidad en 1 (ocupada).
6. El sistema modifica la propiedad de localización del paciente para reflejar la cama de destino.

Postcondiciones:

- La cama de origen queda libre (0).
- La cama de destino queda ocupada (1).
- La ubicación del paciente queda actualizada.

UC-13 – Emitir orden médica de alta

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), según la responsabilidad descrita en la sección 3.2.

Referencia documental: Sección 3.2, definición del rol de Personal Clínico; la entrada de RF-15 contempla una orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado.

Precondiciones:

- El paciente se encuentra hospitalizado e identificado.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico emite la orden médica de alta para el paciente internado.
2. La orden se refiere al paciente hospitalizado identificado.

Postcondiciones:

- La orden médica de alta ha sido emitida por el personal clínico.

UC-13: no existe un requerimiento funcional independiente que detalle la emisión de la orden médica. .

UC-14 – Consultar panel de indicadores hospitalarios

Actor(es) involucrado(s): Director Clínico / Jefe de Área (dirección del hospital).

Referencia documental: RU-DIR-01 y responsabilidades de supervisión de la sección 3.2.

Precondiciones:

- El director clínico/jefe de área tiene acceso autorizado a la función de supervisión.

Flujo principal de eventos:

1. El director clínico solicita consultar el panel de control del sistema.
2. El sistema presenta estadísticas e indicadores del rendimiento clínico.
3. El sistema muestra el porcentaje de ocupación general de camas por áreas.
4. El sistema muestra la cantidad de alertas médicas disparadas.
5. El director clínico revisa los indicadores para apoyar decisiones de gestión.

Postcondiciones:

- El panel de indicadores queda visualizado por el director clínico/jefe de área.

UC-15 – Configurar áreas clínicas y capacidad máxima

Actor(es) involucrado(s): Director clínico / Jefe de área

Referencia documental: RF-06.

Precondiciones:

- Se dispone de un código numérico para el área, un nombre descriptivo y un número entero para definir la capacidad máxima de camas.
- El director clínico / jefe de área está autorizado a hacer estas acciones.

Flujo principal de eventos:

1. Se solicita crear un área hospitalaria.
2. Se ingresan el código numérico, el nombre descriptivo y la capacidad máxima de camas.
3. El sistema comprueba que el código del área sea único.
4. Si el código no está duplicado, el sistema confirma la creación del área.
5. Si el código está duplicado, el sistema deniega la creación.

Postcondiciones:

- Si la operación es aceptada, el área queda creada con su código, nombre y capacidad máxima.
- Si el código está duplicado, el área no se crea y el sistema deniega la operación.

UC-16 – Registrar camas por área y categoría

Actor(es) involucrado(s): Director clínico / Jefe de área

Referencia documental: RF-07.

Precondiciones:

- Existe un área hospitalaria registrada, identificada mediante un código de área existente.

- Se dispone de un ID único de cama y de una categoría de cama.
- El director clínico / jefe de área está autorizado a hacer estas acciones.

Flujo principal de eventos:

1. Se solicita incorporar una cama clínica a un área hospitalaria.
2. Se ingresan el ID de cama, la categoría y el código del área de destino.
3. El sistema asocia la cama al código de un área existente.
4. El sistema incorpora el objeto cama a la lista interna del área correspondiente.

Postcondiciones:

- La cama queda vinculada a la lista interna del área correspondiente, con su ID y categoría.